



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

TERM OF REFERENCE (TOR)
PELATIHAN PENGELOLAAN B3
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TAHUN 2025

TERM OF REFERENCE (TOR)
PENGELOLAAN B3 RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit sebagai sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik, pelayanan medik dan non medik yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Oleh sebab itu rumah sakit wajib memperhatikan keterkaitan antara masalah pengelolaan limbah agar tidak memberikan dampak buruk kesehatan lingkungan di sekitarnya. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu mendapat pengelolaan yang baik termasuk di pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit. Dampak negatif yang sangat mungkin timbul dari pelayanan kesehatan maupun sarana prasarana seperti jarum suntik, limbah dari farmasi, limbah dari radiologi dan yang lainnya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja / penularan penyakit maupun kegawat darurat. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan, rumah sakit menghasilkan limbah yang sangat berbahaya dan beracun yaitu limbah infeksius, patologi, benda tajam, limbah kimia, limbah farmasi, limbah radiologi, limbah dari kegiatan pembersihan dan desinfektan.

Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dapat menimbulkan intoksikasi / keracunan, mengakibatkan luka bakar dan cidera, infeksi gastroenteritis, infeksi saluran pernafasan, AIDS, hepatitis, infeksius mata dan infeksi genital, karsinogen, mutagen dan infeksi kulit. 1 2 Dalam pelaksanaan kegiatan di rumah sakit tentunya akan menghasilkan limbah medis yang merupakan salah satu jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) ialah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat. Memenuhi dengan (Permen LHK No 56 2015), tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan pasal 5 menyatakan bahwa “Pengelolaan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 meliputi tahapan : Pengurangan dan pemilahan limbah B3, Penyimpanan limbah B3, Pengangkutan limbah B3, Pengolahan limbah B3, Penguburan limbah B3 dan atau penimbunan limbah B3 ”.

Rumah Sakit merupakan salah satu sarana yang menjadi sumber penghasil limbah bahan beracun dan berbahaya (LB3). LB3 yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah lingkungan karena sifat LB3 yang beracun, mengandung bahan kimia berbahaya, mudah meledak, mudah bereaksi, korosif, dan mengandung kuman penyakit (infeksius). LB3 yang dihasilkan dari kegiatan RS bersifat infeksius, mengandung bahan kimia, radioaktif yang dihasilkan dari operasional rumah sakit yang berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian, dan laboratorium. Bentuk limbah yang dihasilkan berupa padat, cair, pasta (gel) maupun gas. Berdasarkan penelitian terdahulu permasalahan yang sering terjadi di rumah sakit terkait pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di rumah 3 sakit, mengingat besarnya dampak negatif limbah medis B3 yang ditimbulkan, maka penanganan limbah medis B3 harus dilaksanakan secara tepat, mulai dari pewadahan, pengangkutan, penyimpanan sementara dan pengolahan. Pengelolaan limbah medis B3 yang baik juga didukung dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang Memenuhi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan limbah B3 dan memberikan pelatihan kepada petugas pengelolaan limbah medis B3 agar dapat mencegah kecelakaan kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari literature review yaitu menganalisis penelitian tentang pengelolaan limbah B3 di rumah sakit dan memberikan hasil review berdasarkan peraturan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang ini menjadi dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup, termasuk limbah B3.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai pengelolaan limbah B3, termasuk identifikasi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan ini secara khusus mengatur pengelolaan limbah medis yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah B3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan ini mengatur lebih detail mengenai pengelolaan limbah B3 di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk izin pengelolaan limbah B3.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Karyawan dapat memahami tata cara pengelolaan B3 di Rumah Sakit.
2. Tujuan
 - a. Karyawan paham menggunakan spilkit B3.
 - b. Karyawan paham logo – logo B3.
 - c. Karyawan paham prinsip penanganan tumpahan B3.
 - d. Karyawan paham penempatan dan penyimpanan B3.
 - e. Karyawan paham fungsi MSDS.

D. Indikator keberhasilan

1. Karyawan dapat menggunakan spilkit B3.
2. Karyawan tahu arto logo – logo B3.
3. Karyawan mampu mengaplikasikan prinsip penanganan tumpahan B3.
4. Karyawan dapat menempatkan dan penyimpanan B3 yang baik dan benar.
5. Karyawan mengerti manfaat MSDS.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Susunan Panitia

NO	SUSUNAN PANITIA	NAMA	TUGAS
1	Ketua Panitia	Faisal Aminuddin Ilham, S.KM	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara.
2	Sekretaris	Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi	Bertanggung jawab terhadap pendokumentasian seluruh dokumen dan notulen
3	Bendahara	Novi Ratnasari, SE	Bertanggung jawab terhadap anggaran dana Diklat
4	Sie Dokumentasi	Maja Tito Sadewo, S.Kom	Bertanggung jawab terhadap dokumentasi Diklat
5	Sie Penunjang	Erik Ardianata	Bertanggung jawab mengkoordinir peserta untuk patuh dengan jadwal pelatihan.

B. Waktu Pelaksanaan

1. Tanggal : Senin, 07 Juli 2025
2. Pukul : 08.00 WIB s/d 14.45 WIB
3. Tempat : Hall Sakura

C. Rencana Rapat Panitia Penyelenggaraan

1. Tanggal : Sabtu, 05 Juli 2025
2. Pukul : 10.00 WIB
3. Tempat : Ruang Rapat Managemen 5C

D. Sasaran atau Peserta

1. Seluruh Staf RS Prima Husada sejumlah 401
2. Seluruh Staf Klinik Mutiara Sehat sejumlah 35

E. Susunan Acara Lengkap

NO	JAM	DURASI	MATERI	PETUGAS
Gelombang 1				
1	08.00-08.05	5 menit	Absensi dan pretest	Tim
2	08.05-08.20	15 menit	Pemaparan alur penanggulangan kebakaran dan gempa bumi Rumah Sakit	Faisal Aminuddin Ilham, S.KM
3	08.20-08.30	10 menit	Praktek menggunakan Spillkit	Tim
Gelombang 2				
1	13.00-13.05	5 menit	Absensi dan pretest	Tim
2	13.05-13.20	15 menit	Pemaparan alur penanggulangan kebakaran dan gempa bumi gempa Rumah Sakit	Faisal Aminuddin Ilham, S.KM
3	13.20-13.30	10 menit	Praktek menggunakan Spillkit	Tim
Gelombang 3				
1	14.15-14.20	5 menit	Absensi dan pretest	Tim
2	14.20-14.35	15 menit	Pemaparan alur penanggulangan kebakaran dan gempa bumi Rumah Sakit	Faisal Aminuddin Ilham, S.KM
3	14.35-14.45	10 menit	Praktek menggunakan spillkit	Tim

F. Narasumber / Pemateri

Faisal Aminuddin Ilham, S.KM

G. Media

1. LCD
2. Laptop
3. Soeaker
4. Spillkit

H. Metode

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Praktek
4. Tanya Jawab

I. Kebutuhan Anggaran

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	KEGIATAN	KEBUTUHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA	SUMBER DANA
1	7 Juli 2025	Diklat MFK B3	Pemateri	1 Orang	Rp.0,-	Rp.0,-	Kebutuhan akreditasi
			Konsumsi Pemateri dan Panitia	5 Orang Selama 3 gelombang	Rp.5.000,-	Rp.75.000,	Dapur RS Prima Husada
			Air Mineral Gelas	436 Pcs (9 Dus)	Rp.25.000,-	Rp.225.000,-	
TOTAL BIAYA						Rp.300.000,-	PT DPM

III. MONITORING – EVALUASI

- Monitoring

Monitoring dilakukan selama kegiatan berlangsung
- Evaluasi

Evaluasi diklat dilakukan oleh kepala ruang masing – masing dan disupervisi oleh Komite K3RS

IV. PENUTUP

Demikian TOR ini kami buat sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan ini. Suksesnya acara ini memerlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh staf yang ada dan agar tujuan orientasi tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Malang, 02 Juli 2025
SDM RS Prima Husada

Ketua Panitia

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi

Faisal Aminuddin Ilham, S.KM

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah